Baustein Arbeitszeit

Baustein für die Gefährdungsbeurteilung · PflegefuerPflegen · BEISPIELDATEN (erfundene Station)

Zeitraum: 9.10.2026 bis 20.11.2026 · Erstellt: 6.11.2026, 16:27:53

Grundlage: erfundene Beispiel-Station zum Ansehen.

Ergebnis auf einen Blick

92 % der Schichtwechsel hatten mindestens 11 Stunden Ruhezeit (383 von 417).

Personen in der Auswertung	18
Schichten im Zeitraum	503
davon Nachtschichten	132
Durchschnittliche Ruhezeit zwischen Schichten	19 h 23 min

Rechtsgrenzen (Arbeitszeitgesetz) – Prüfhinweise

Prüfhinweis heißt: Das Gesetz sieht hier eine Grenze vor (§ 5 Abs. 1 ArbZG: 11 Stunden Ruhe; § 3 ArbZG: 10 Stunden Arbeitstag). Ob eine Ausnahme greift – in Pflegeeinrichtungen 10 Stunden mit Ausgleich (§ 5 Abs. 2 ArbZG), Tarifvertrag oder kirchliche Arbeitsrechtsregelung (§ 7 ArbZG) –, entscheidet die Einrichtung. Dieser Bericht bewertet das nicht.

Ruhezeit unter 11 Stunden	34
davon unter 10 Stunden	34

unter 10 h greift auch die Pflege-Ausnahme nicht mehr; nur Tarifvertrag/AVR

davon unter 8 Stunden	0
Arbeitstage über 10 Stunden	0

Ausgleichskonto nach § 5 Abs. 2 ArbZG

Jede Verkürzung unter 11 Stunden braucht innerhalb eines Kalendermonats oder von vier Wochen eine andere Ruhezeit von mindestens 12 Stunden. Gezählt wird, ob eine solche Ruhezeit im Plan folgt (jede 12-Stunden-Ruhe gleicht eine Verkürzung aus; Fenster: das spätere von Monatsende und 28 Tagen).

Verkürzte Ruhezeiten im Zeitraum	34
Ausgleich im Plan gefunden	30
Ausgleich offen (Frist läuft)	4
Prüfhinweis: Ausgleich bis Fristende nicht im Plan	0

Empfehlungen (Arbeitswissenschaft)

Keine Rechtsgrenzen, sondern Gestaltungsempfehlungen: vorwärts rotieren, wenige Nächte am Stück, ausreichend Erholung nach dem Nachtblock.

Wechsel Nacht -> Früh (innerhalb 48 h)	15
Weitere Rückwärtswechsel am Folgetag	0
Nachtserien mit mehr als 3 Nächten	21
6 oder mehr Arbeitstage am Stück	0

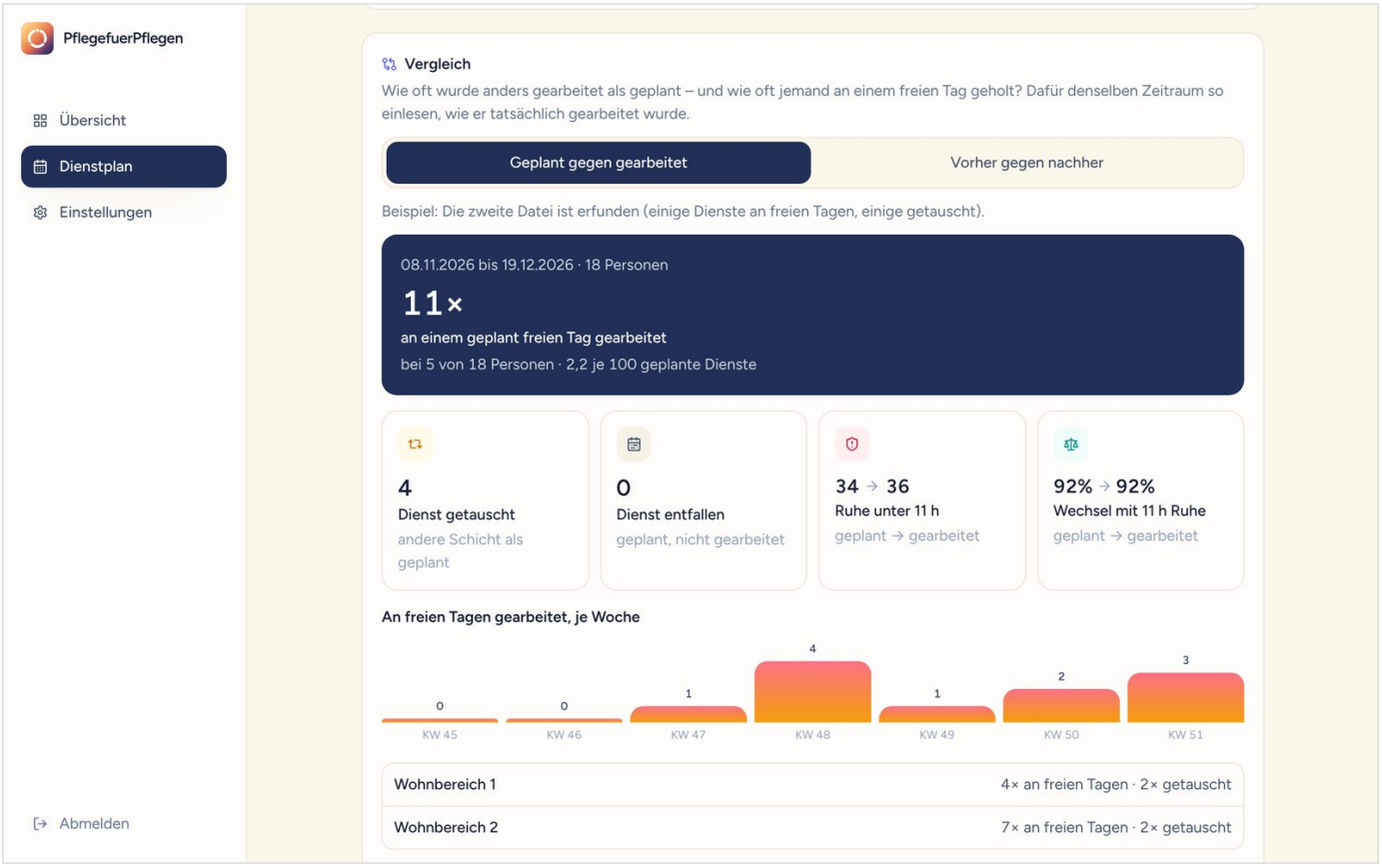
Vergleich: geplant gegen gearbeitet

Das Dienstplanprogramm zeigt, was geplant war. Dieser Teil zeigt, was danach wirklich gearbeitet wurde. Dafür liest die Einrichtung denselben Zeitraum ein zweites Mal ein, so wie tatsächlich gearbeitet wurde. Gezählt wird unter anderem, wie oft jemand an einem geplant freien Tag gearbeitet hat (Holen aus dem Frei).

Ergebnis auf einen Blick

An einem geplant freien Tag gearbeitet	**11× · bei 5 von 18 Personen · 2,2 je 100 geplante Dienste**
Dienst getauscht (andere Schicht als geplant)	**4**
Dienst entfallen (geplant, nicht gearbeitet)	**0**
Ruhezeit unter 11 Stunden	**34 geplant -> 36 gearbeitet**
Schichtwechsel mit mindestens 11 Stunden Ruhe	**92 % -> 92 %**
Je Wohnbereich	**WB 1: 4× Frei, 2× getauscht · WB 2: 7× Frei, 2× getauscht**
An freien Tagen gearbeitet, je Woche	**KW 45: 0 · KW 46: 0 · KW 47: 1 · KW 48: 4 · KW 49: 1 · KW 50: 2 · KW 51: 3**

So sieht der Vergleich in PflegefuerPflegen aus (Beispieldaten):



Vorher gegen nachher: Wirkt das Ausfallkonzept?

Mit derselben Auswertung vergleicht die Einrichtung zwei Zeiträume, zum Beispiel vor und nach Einführung eines Springerpools. Die Werte werden je 100 Schichtwechsel gerechnet, damit unterschiedlich lange Zeiträume vergleichbar sind. So wird sichtbar, ob seltener aus dem Frei geholt wird und ob kurze Ruhezeiten abnehmen. Das Ergebnis lässt sich als Wirksamkeitsprüfung in der Gefährdungsbeurteilung eintragen (§ 3 und § 6 ArbSchG) und für die Dokumentation von Maßnahmen zum Ausfallmanagement nutzen.

Prüfhinweise, keine Urteile: Ob eine Abweichung zulässig ist (z. B. nach Tarifvertrag oder AVR), bewertet die Einrichtung. Nur Gruppen ab fünf Personen, keine Namen.

Häufigste enge Wechsel

Spät -> Früh	34×

Befunde und Maßnahmen

Je Befund: wo er im Plan steht, welche Art von Risiko es ist, was die Forschung dazu sagt und welche Maßnahmen Fachstellen vorschlagen. Darunter trägt die Einrichtung ihre eigene Entscheidung ein (§ 6 ArbSchG: Ergebnis, festgelegte Maßnahmen, Ergebnis der Überprüfung). Die Felder lassen sich im PDF ausfüllen oder ausgedruckt von Hand.
Die Schwellen der Empfehlungen (mehr als 3 Nächte, 6 Arbeitstage am Stück, Nacht vor Früh innerhalb von 48 Stunden) orientieren sich an den genannten Quellen; es sind keine gesetzlichen Grenzen. Die Quellen stehen mit Link am Ende dieses Teils.
Ergänzend: Pflegekräfte können in der App PflegefuerPflegen Empfehlungen zu Schlaf, Pausen und Essen passend zu ihrem eigenen Dienstplan nutzen. Das unterstützt das eigene Verhalten und ersetzt keine Maßnahme an der Dienstplangestaltung. Die Leitung sieht davon nie Einzelangaben.

Angaben der Einrichtung zu dieser Beurteilung

Beurteilt von (Funktion, z. B. PDL, Sifa):	Datum der Beurteilung:	Nächste Überprüfung geplant am:

1. Ruhezeit 8 bis unter 10 Stunden

Fundstelle: Wohnbereich 1 · KW 41 (1×), KW 42 (4×), KW 43 (1×), KW 44 (3×), KW 45 (3×), KW 46 (2×), KW 47 (2×) · zusammen 16×

Risiko-Typ: Gesetzlicher Prüfhinweis

Auswirkung und Evidenz: Weniger als 10 Stunden zwischen zwei Diensten verkürzen die Zeit für Schlaf. Bei Pflegekräften gingen kurze Wechsel mit mehr Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit und Krankmeldungen einher; sie können diese Belastungen erhöhen.
Vorschläge für Maßnahmen (die Einrichtung entscheidet):

- Spät -> Früh aus dem Grundplan streichen; wenn nötig Spät -> frei -> Früh planen.
- Prüfen, ob ein Tarifvertrag oder eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung diese Verkürzung vorsieht, und deren Grenzen (Anzahl, Ausgleich) als Planungsregel hinterlegen.
- Dienstbeginn mit Gleitfenster planen (z. B. Frühdienst nach Wahl zwischen 5:30 und 6:30 Uhr), damit die Abstände länger werden.

Hinweis: Unter 10 Stunden greift die Pflege-Ausnahme nach § 5 Abs. 2 ArbZG nicht. Tarifverträge oder Dienstvereinbarungen können nach § 7 ArbZG abweichen; das prüft die Einrichtung.
Quellen: Eldevik u. a. 2013 (Pflegekräfte); Vedaa u. a. 2017 (Krankmeldungen); Djupedal u. a. 2024 (Studie ohne kurze Wechsel); AWMF-Leitlinie Nacht- und Schichtarbeit (2021); BAuA: Schichtarbeit gesund gestalten (engl.); KomNet NRW: Verkürzung der Ruhezeit

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

2. Ruhezeit 8 bis unter 10 Stunden

Fundstelle: Wohnbereich 2 · KW 41 (1×), KW 42 (3×), KW 43 (2×), KW 44 (2×), KW 45 (4×), KW 46 (4×), KW 47 (2×) · zusammen 18×

Risiko-Typ: Gesetzlicher Prüfhinweis

Auswirkung, Vorschläge und Quellen: wie bei Befund 1.

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

3. Ausgleich nach § 5 Abs. 2 ArbZG noch offen

Fundstelle: Wohnbereich 1 · KW 47 (2×) · zusammen 2× · Ausgleich einplanen bis 17.12.2026

Risiko-Typ: Gesetzlicher Prüfhinweis

Auswirkung und Evidenz: Der 12-Stunden-Ausgleich für eine verkürzte Ruhezeit steht noch nicht im Plan, die Frist läuft noch. Ohne Ausgleich bleibt es bei der kürzeren Erholung; kurze Wechsel können Schlafprobleme und Erschöpfung erhöhen.

Vorschläge für Maßnahmen (die Einrichtung entscheidet):

- Den Ausgleich jetzt fest einplanen: eine Ruhezeit von mindestens 12 Stunden vor Ende der Frist.
- Offene Ausgleiche als Liste mit Frist und zuständiger Rolle (z. B. Wohnbereichs- oder Stationsleitung) führen und wöchentlich prüfen.
- Bei Diensttausch oder Einspringen darauf achten, dass ein geplanter Ausgleich nicht wegfällt.

Hinweis: Tarifverträge, AVR oder Dienstvereinbarungen können andere Ausgleichszeiträume vorsehen. Ob eine solche Regel gilt, prüft die Einrichtung.

Quellen: § 5 ArbZG; Dahlgren u. a. 2016 (Pflegekräfte); GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation; KomNet NRW: Verkürzung der Ruhezeit

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

4. Ausgleich nach § 5 Abs. 2 ArbZG noch offen

Fundstelle: Wohnbereich 2 · KW 47 (2×) · zusammen 2× · Ausgleich einplanen bis 15.12.2026

Risiko-Typ: Gesetzlicher Prüfhinweis

Auswirkung, Vorschläge und Quellen: wie bei Befund 3.

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

5. Nacht direkt vor Früh

Fundstelle: Wohnbereich 1 · KW 44 (1×), KW 45 (2×), KW 46 (4×), KW 47 (2×) · zusammen 9×

Risiko-Typ: Arbeitswissenschaftliche Belastung

Auswirkung und Evidenz: Nach Nachtdiensten ist der Tagschlaf meist kürzer und schlechter; ein Frühdienst kurz danach kann Müdigkeit im Dienst erhöhen. Die BAuA empfiehlt nach Nachtdiensten nie weniger als 24, besser 48 Stunden Ruhe.

Vorschläge für Maßnahmen (die Einrichtung entscheidet):

- Nach dem letzten Nachtdienst eines Blocks mindestens 48 Stunden frei planen (nie unter 24 Stunden).
- Planungsregel hinterlegen: kein Frühdienst innerhalb von 48 Stunden nach Ende eines Nachtdienstes.
- Den Frühdienst nicht zu früh beginnen lassen (möglichst nach 6 Uhr oder mit Gleitfenster).

Hinweis: Grundlage sind Empfehlungen der Arbeitswissenschaft; Studien genau zu diesem Wechsel in der Pflege fehlen bisher.

Quellen: BAuA: Schichtarbeit gesund gestalten (engl.); Shiffer u. a. 2018 (Pflegekräfte); BGHM: Gestaltung von Schichtarbeit (2025); DGUV: Lage der Arbeitszeit

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

6. Nacht direkt vor Früh

Fundstelle: Wohnbereich 2 · KW 43 (2×), KW 44 (2×), KW 45 (1×), KW 47 (1×) · zusammen 6×

Risiko-Typ: Arbeitswissenschaftliche Belastung

Auswirkung, Vorschläge und Quellen: wie bei Befund 5.

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

7. Mehr als 3 Nächte am Stück

Fundstelle: Wohnbereich 1 · KW 42 (2×), KW 43 (3×), KW 44 (1×), KW 45 (3×), KW 46 (2×), KW 47 (1×) · zusammen 12×

Risiko-Typ: Arbeitswissenschaftliche Belastung

Auswirkung und Evidenz: Mit jeder weiteren Nacht in Folge kann das Unfall- und Verletzungsrisiko steigen; in einer Auswertung lag es in der vierten Nacht etwa 36 % höher als in der ersten. Fachgremien empfehlen höchstens drei Nachtdienste hintereinander.

Vorschläge für Maßnahmen (die Einrichtung entscheidet):

- Nachtdienstblöcke auf höchstens 3 Nächte begrenzen.
- Nach jedem Nachtblock mindestens 48 Stunden frei planen (nie unter 24 Stunden).
- Nachtdienste auf mehr Personen verteilen (z. B. Nacht-Pool, feste Tauschregeln) und Wünsche von Dauernachtwachen gesondert besprechen.

Hinweis: Die Empfehlung zielt auf wechselnde Dienste. Für feste Dauernachtwachen ist die Studienlage unklar; die Einrichtung entscheidet mit Begründung.

Quellen: Folkard & Tucker 2003 (Occup Med); SBU 2018: Nachtdienste in der Pflege planen; Garde u. a. 2020 (Scand J Work Environ Health); DGUV: Lage der Arbeitszeit; AWMF-Leitlinie Nacht- und Schichtarbeit (2021); BAuA: Schichtarbeit gesund gestalten (engl.)

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

8. Mehr als 3 Nächte am Stück

Fundstelle: Wohnbereich 2 · KW 41 (1×), KW 43 (3×), KW 44 (2×), KW 45 (1×), KW 46 (2×) · zusammen 9×

Risiko-Typ: Arbeitswissenschaftliche Belastung

Auswirkung, Vorschläge und Quellen: wie bei Befund 7.

Handlungsbedarf (ja / nein):	Betriebsrat / MAV / Personalrat beteiligt am:	Verantwortlich für die Umsetzung (Rolle):

Vom Arbeitgeber tatsächlich festgelegte Maßnahme vor Ort:

Umsetzen bis (Frist):	Umgesetzt am:	Wirksamkeit geprüft am:

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung:

Quellen zu den Befunden

Eldevik u. a. 2013 (Pflegekräfte)
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070882

Vedaa u. a. 2017 (Krankmeldungen)
https://oem.bmj.com/content/74/7/496

Djupedal u. a. 2024 (Studie ohne kurze Wechsel)
https://academic.oup.com/sleep/article/47/7/zsae086/7641764

AWMF-Leitlinie Nacht- und Schichtarbeit (2021)
https://register.awmf.org/assets/guidelines/002-030k_S2k_Gesundheitliche-Aspekte-Gestaltung-Nacht-und-Schichtarbeit_2021-08.pdf

BAuA: Schichtarbeit gesund gestalten (engl.)
https://baua.de/EN/Topics/Work-design/Working-time/Night-and-shift-work

KomNet NRW: Verkürzung der Ruhezeit
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/26234

§ 5 ArbZG
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__5.html

Dahlgren u. a. 2016 (Pflegekräfte)
https://cronfa.swansea.ac.uk/Record/cronfa26712

GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation
https://www.bgbau.de/fileadmin/Themen/Arbeitsschutz/Ergonomisches_Arbeiten/GDA_-Leitlinie-Gefaehrdungsbeurteilung.pdf

Shiffer u. a. 2018 (Pflegekräfte)
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/9/2038

BGHM: Gestaltung von Schichtarbeit (2025)
https://cdn.vbg.de/media/354264be83a84866af38fe7c27afad8b/dld:attachment/Gestaltung%20von%20Schichtarbeit_S%20Neisecke_%2019.03.2025.pdf

DGUV: Lage der Arbeitszeit
https://dguv.de/fb-gesundheitimbetrieb/sachgebiete/sg-psyche/erfahrungsschatz/arbeitszeit/lage-der-arbeitszeit/index.jsp

Folkard & Tucker 2003 (Occup Med)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12637593/

SBU 2018: Nachtdienste in der Pflege planen
https://sbu.se/en/publications/responses-from-the-sbu-enquiry-service/scheduling-of-night-shifts-for-care-and-help-nurse-personnel

Garde u. a. 2020 (Scand J Work Environ Health)
https://www.sjweh.fi/article/3920

Stand der Quellen: geprüft am 6.11.2026.

GB-Baustein Arbeitszeit

Monatswerte für den Bereich Arbeitszeit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung (§§ 5, 6 ArbSchG; GDA-Leitlinie, Merkmalsbereich Arbeitszeit). Gruppenwerte, keine Einzelpersonen. Methode, Bewertung und Maßnahmen legen Arbeitgeber und Betriebsrat/MAV fest – dieser Baustein liefert Daten, keine Beurteilung.

Monatswerte (Gruppenwerte)

Monat	Schichten	Nächte	>= 11 h Ruhe	< 11 h	< 10 h	Ausgl. offen	Ausgl. fehlt	Nacht->Früh	> 10 h Tag
Oktober 2026	276	64	93 %	16	16	0	0	4	0
November 2026	227	68	91 %	18	18	4	0	11	0

„Ausgl. offen“: Frist nach § 5 Abs. 2 ArbZG läuft noch. „Ausgl. fehlt“: bis Fristende keine Ruhezeit von 12 Stunden im Plan gefunden – Prüfhinweis für die Einrichtung.

Fünf Merkmale des Bereichs Arbeitszeit

1. Dauer

Arbeitstage über 10 Stunden; Schichten je Monat.
Daten aus dem Dienstplan: 0 Arbeitstage über 10 h im Zeitraum
Maßnahme: _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____ Wirksamkeit geprüft am: _____

2. Lage

Nachtanteil, Nacht->Früh-Wechsel, Rückwärtswechsel, Nachtserien.
Daten aus dem Dienstplan: 132 Nächte · 15× Nacht->Früh · 21 Nachtserien
Maßnahme: _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____ Wirksamkeit geprüft am: _____

3. Vorhersehbarkeit

Aus dem Plan allein nicht ableitbar: Vorlauf des Dienstplans.
Daten aus dem Vergleich (Seite 2): 11× aus dem Frei geholt, 4 Dienste getauscht, 0 entfallen.
Maßnahme: _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____ Wirksamkeit geprüft am: _____

4. Pausen und Ruhezeiten

Ruhezeiten unter 11 h, Ausgleichskonto; Pausen sind im Plan nicht enthalten.
Daten aus dem Dienstplan: 34× unter 11 h · 4 Ausgleiche offen · 0 nicht gefunden
Maßnahme: _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____ Wirksamkeit geprüft am: _____

5. Erreichbarkeit

Aus dem Plan nicht ableitbar: Rufbereitschaft, Erreichbarkeit im Frei.
Daten aus dem Dienstplan: Bitte ergänzen
Maßnahme: _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____ Wirksamkeit geprüft am: _____

Datenschutz

Beispieldaten einer erfundenen Station, keine echten Personen.

Hinweis: Diese Auswertung basiert auf einer mathematisch-strukturellen Analyse eines erfundenen Beispiel-Dienstplans. Die angezeigten Risiken und Maßnahmen-Vorschläge berufen sich auf gesetzliche Vorgaben und arbeitswissenschaftliche Studien. Sie dienen als Orientierungs- und Assistenz-Werkzeug. Die finale Festlegung der Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Gesamtverantwortung für die Gefährdungsbeurteilung verbleiben gemäß § 5 ArbSchG vollumfänglich beim Betreiber der Einrichtung. Ob für eine Grenze eine Ausnahme greift (zum Beispiel Tarifvertrag, AVR oder § 5 Abs. 2 ArbZG), entscheidet die Einrichtung. Diese Auswertung ist keine Rechtsberatung.